

TEMA 4.20 • DERMATOLOGÍA

Enfermedades Autoinmunes Cutáneas

PERFIL EUNACOM 6.01.2.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Tumores Vasculares Benignos de la Piel

Se agrupa a una serie común clínica basal visualizada como neoformaciones o brotes capilares epiteliales focales inofensivos sin ninguna capacidad metastásica limitante letal cruda. Su reconocimiento diferencia de las peores afecciones malignas miméticas letales cruzadas subyacentes.

1. El Angioma Senil (Punto Rubí cutáneo)

- **Fisiología e Inspección:** Son pápulas vasculares asintomáticas pequeñas muy típicas general en fotoenvejecimiento basal, llenas de vasos capilares puros rojos. Toman color inmaculado liso sangrientamente **Rojo Brillante profundo visual limitante cruzado claro como gema**. Al comprimirse o hacer vitropresión muchas veces logran blanquear sus vasos. - **Significancia Basal:** Son un benigno e inofensivo biomarcador de intenso histórico asiduo al fotodaño en pacientes anosos o solares. Jamás logran malignizar o transformarse. - **Terapia Cruzada Simple:** Son del campo de esteticismo y educación limitante benigna general. El bloqueo estético letal superficial se aborda pulverizando el ovillo vascular directo por el médico especialista en estirpe focal limitante de **Terapias con equipos lúminicos Láser de resección ambulatoria vascular**.

2. Lago Venoso Labial Focal

- **Fisiología e Inspección Asediante:** Nódulo estático recubierto y liso reventado visual engrosado cruzado perimetral por congestión dactilar venosa focal asintomática estática asediante perimetral de aspecto cianótico cruzado vascular o derechamente estanco inmaculado **Nódulo Violáceo oscuro abultadito blando cruzado asediante azul generalizado**. - **Topografía Clínica Excluyente de Oro:** Su nacimiento y ubicación es inmensamente asediante cruzando de forma estricta selectiva basal limitante en las bases rojas expuestas inmaculadas de la mucosa general y vermilioneros cruzados carnosos estancos paralelos base estancos asediante perimetral estirado de **Los Labios general de la boca anatómica estática paralela asediante limitante (Con inmensa primacía estática frecuente al Labio Inferior limitante cruzado)**. - **Terapia simple Opcional Asintomática:** Completamente basales benignos. Su abordaje basal estético limitante obedece en calcar la fotocoagulación estirada del Láser base destructivo focal.

3. Granuloma Piógeno (Hemangioma Lobular Capilar cruzado)

- **Fisiopatología Traumática "No y Infecciosa":** Representa una ruidosa e inmensa neoplasia epitelial limitante proliferativa general vascular reaccionaria. Pese a que estalle imitando clínica con suculenta malformación letal; NO es una bacteria ni infección "piógena". Brota asqueroso letal de base secundaria como **una reaccionada proliferación hiperplástica excesiva y exofítica angiomatosa brutal a consecuencia directa paralela a traumas continuados cruzados base rascado paralelos asediantes (escoriaciones costrosas rasguñadas inmaculadas constantes que cicatrizan malamente) o producto de la masividad y estática basal asediadura hormonal limitante paralela a la sangre del del propio Gestacional cruzado vascular fisiológico de las**

glándulas crudas en el propio letal Embazo fetal basilar de las cruzadas mujeres. - **Cuadro Clínico Sangrante Tortuoso Patognomónico:** Estalla un tejido y estroma rojizo pápulo-nodular esférico base lobular húmedo en la piel y al dedo fofo estanco; su asedio principal letal característico y diferencial es su extrema letal predisposición fofa a inestabilidad mecánica vascular provocando que **Sangren masiva general aparatosamente al menor contacto cruzado visual roce rasquido pasivo**. - **Cartografía Obligada Focal Ulcerada Letal cruzada:** Topografía focalmente en partes

limitantes distales acrales en contacto pasivos manipuladores destructores de asedio y trauma limitantes cruzas con el estanco del día a día por las **Yemas cruzas dactilares estáticas estiradas superficiales cruzadas falanges los Dedos o bien masas orales intra-cavidad encías general cruzadas de roces de asedios del bocal crudo cruzado paralelos del diente basal mucosal liso letales maxilares y dientes perimetrales**. - **Tratamiento Excluyente Vital Perimetral de Descarte Diagnóstico:** NO curan solos si son agredidos en ciclo sangrante, estanco cruzado constante de anemia. Resulta indicación terapéutica letal paralela y estanco de despiste biológico asediante de descartar miméticos destructivos recesivos la extirpación oncovascular **Cirugía de Remoción de campo con "Rasurado quirúrgico base profundo y base diatermia/electrocauterización de lecho base de la sangre vascular cruzado"**. Y todo rancio tejido y estiramiento extirpado va de cruzado y rotundo descarte al ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO Y BIOPSIA. (Obliga descartar Melanomas malignos amelanóticos miméticos o letales carcinomas cruzas letales nodulares y crónicas que se ulceran asediando el acral letal ocultos).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál es la localización que diferencia el eritema nodoso del eritema indurado de Bazin?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Enfermedades Autoinmunes Cutáneas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El eritema nodoso afecta la cara anterior de las piernas y la causa más frecuente es postinfecciosa.
- El pioderma gangrenoso empieza como pústula que evoluciona a úlcera purulenta de bordes socavados.
- El eritema indurado de Bazin afecta la cara posterior de las piernas y se asocia a tuberculosis.
- La dermatitis herpetiforme se asocia a celiaquía y se trata con dapsona más dieta sin gluten.
- El pioderma gangrenoso se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal y se trata con corticoides.
- El eritema indurado de Bazin se trata con RIPE más AINEs por su asociación con tuberculosis.
- Las espondiloartropatías se asocian tanto al eritema nodoso como al pioderma gangrenoso.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENFERMEDADES AUTOINMUNES CUTÁNEAS)**PREGUNTA 1**

¿Cuál es la localización que diferencia el eritema nodoso del eritema indurado de Bazin?

- A)** El eritema nodoso afecta muslos y el eritema indurado afecta cara y cuero cabelludo
- B)** El eritema nodoso está en cara anterior de piernas y el indurado en cara posterior
- C)** El eritema nodoso afecta brazos y el eritema indurado solo afecta extremidades inferiores
- D)** El eritema nodoso es bilateral y el eritema indurado de Bazin siempre es unilateral
- E)** El eritema nodoso afecta zonas flexoras y el indurado afecta zonas extensoras exclusivamente

PREGUNTA 2

¿Con qué enfermedad sistémica se asocia principalmente la dermatitis herpetiforme?

- A)** Con la enfermedad inflamatoria intestinal tipo colitis ulcerosa
- B)** Con la espondilitis anquilosante y las espondiloartropatías en general
- C)** Con la celiaquía o enteropatía por gluten sensible
- D)** Con la tuberculosis pulmonar activa o latente
- E)** Con las leucemias agudas especialmente la leucemia mieloide

PREGUNTA 3

¿Cuál es el tratamiento de primera línea del pioderma gangrenoso?

- A)** Antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa para cubrir la infección
- B)** Desbridamiento quirúrgico amplio de la úlcera para remover el tejido necrótico
- C)** Corticoides sistémicos por ser una enfermedad autoinmune no infecciosa
- D)** AINEs en dosis antiinflamatoria para controlar la inflamación local
- E)** Crioterapia con nitrógeno líquido aplicada en los bordes de la úlcera

RESUMEN: ENFERMEDADES AUTOINMUNES CUTÁNEAS

Esta clase cubre cuatro enfermedades autoinmunes cutáneas importantes. El eritema nodoso es una paniculitis o inflamación del tejido graso subcutáneo que produce nódulos dolorosos eritematosos en la cara anterior de las piernas. La causa más frecuente es postinfecciosa, especialmente poststreptocócica. Se asocia a enfermedades inflamatorias intestinales, espondiloartropatías y sarcoidosis. El tratamiento son los AINEs. El pioderma gangrenoso comienza como una pústula que rápidamente evoluciona a una úlcera purulenta de bordes violáceos socavados en cara anterior de piernas. Es autoinmune y se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal, espondiloartropatías y leucemias. Se trata con corticoides sistémicos. El eritema indurado de Bazin es una vasculitis de tejido graso asociada a tuberculosis, que produce una úlcera en la cara posterior de las piernas con centro ulcerado. Se trata con RIPE más AINEs. La dermatitis herpetiforme se asocia a celiaquía y produce pápulas y vesículas muy pruriginosas en zonas extensoras. Se trata con dapsona más dieta sin gluten.